

健康问诊报告

报告编号: R19

用户: chen

问诊时间: 2026-04-17 09:15:00

结束时间: 2026-04-17 09:43:00

【主诉】

心悸伴胸闷3天, 偶有头晕

【对话记录】

患者: 心悸伴胸闷3天, 偶有头晕

AI 医生: 您好! 我是 AI 辅助问诊助手, 我会根据医学知识库为您提供参考建议。

为了给您更准确的回复, 请尽量描述:

- **主要症状** (如头痛、发烧、咳嗽等)
- **持续时间** (几小时/几天)
- **严重程度** (轻微/明显/剧烈)
- **伴随症状** (如有)

请注意: 本系统仅供参考, 不能替代专业医生诊断, 如症状严重请及时就医。

患者: 我最近三天总感觉心跳很快, 有时候胸口发闷, 昨天下午站起来的时候头晕了一下, 感觉心跳有点乱, 会"漏跳"一下那种感觉, 但过几秒又自己好了, 不知道是不是心脏有问题。

AI 医生: 收到您的描述, 我来为您进行初步辅助评估。

****症状梳理****

- 阵发性心悸伴"漏跳感", 持续3天
- 阵发性胸闷

- 体位性头晕（站立时发作一次）

心悸、胸闷与体位性头晕的组合需要重点关注心血管系统与自主神经功能，为了提供更有针对性的分析，请补充以下信息：

- 1. 心悸发作时大概持续多久？是突然开始突然终止，还是逐渐缓解？
- 2. 胸闷时有没有伴随**胸痛、后背放射痛或左臂麻木**？
- 3. 近期睡眠和工作压力状况如何？
- 4. 是否有饮用浓茶、咖啡的习惯？近期有无感冒发热史？

患者：每次发作大概5到10秒，突然来突然好，没有胸痛和手臂麻木。最近工作压力挺大，差不多凌晨两三点才睡，睡眠很浅容易醒。平时喝咖啡，最近一周每天两杯左右。上周有点轻微流涕，已经好了。

AI 医生：感谢补充，以下是系统基于您症状特征与知识库检索结果给出的辅助分析：

****辅助诊断分析****

****重点考虑：功能性心律失常（室上性期前收缩）****

您描述的"阵发性心悸伴漏跳感、5~10秒突发突止"是**期前收缩（早搏）**的典型临床表现。结合近期咖啡摄入量增加、睡眠严重不足（凌晨2~3点入睡）、持续工作压力，上述因素均为功能性期前收缩的常见诱因，可导致交感神经兴奋性升高、心肌自律性增强。大多数功能性早搏无需特殊药物治疗，去除诱因后可自行缓解。

****同时考虑：体位性低血压****

站立时出现头晕提示从坐/卧位起立时血压短暂下降，在睡眠质量差、自主神经调节能力下降的人群中较为常见。

****需排除：甲状腺功能亢进****

甲亢可引起持续性心悸、心率加快，虽然您的心悸为阵发性且时间短暂，暂不典型，但仍建议查甲功五项予以排除。

****关于上周流涕史****：若症状在感冒后加重需警惕病毒性心肌炎，建议同步检查心肌酶谱。

请问您此前有无心脏病史或家族遗传性心脏病史？

患者：没有心脏病史，家里人也没有。我就是担心是不是因为最近太累了，需不需要去医院检查？

AI 医生：综合您提供的全部信息，系统生成以下辅助诊断报告：

辅助诊断综合评估报告

****主诉****：心悸伴胸闷3天，偶有体位性头晕

****相关因素****：睡眠不足、咖啡因摄入增加、工作压力大、近期轻微上呼吸道感染史

综合分析

目前症状最可能的病因为****自主神经功能紊乱合并功能性室上性期前收缩****。慢性睡眠剥夺与持续心理压力导致交感神经持续亢奋，直接诱发阵发性心悸与偶发早搏；体位性头晕则与自主神经调节能力下降、血压调控延迟有关。既往无心脏病史，现阶段无胸痛、晕厥、呼吸困难等高危征象，整体风险处于中等水平。

建议检查项目

检查项目	临床意义
-----	-----
12导联心电图	明确心律失常类型
24小时动态心电图 (Holter)	定量评估期前收缩负荷

| 卧立位血压 | 确认体位性低血压 |

| 血常规 | 排除贫血所致心悸 |

| 甲状腺功能五项 | 排除甲亢 |

| 心肌酶谱（cTnI、CK-MB） | 结合近期感冒史，排除心肌炎 |

生活方式干预

- **睡眠**：尽量23:30前就寝，睡前1小时停用手机，保证7~8小时睡眠
- **咖啡因**：午后避免咖啡及浓茶，每日控制在1杯以内
- **运动**：每天快走30分钟，有助于改善自主神经调节功能
- **压力管理**：可尝试腹式呼吸或正念放松练习

就医建议

****建议3~7天内至心内科门诊就诊****，携带上述检查结果交由医生综合判断。若出现以下情况请****立即就医****：

- 心悸持续超过30分钟不缓解
- 伴随明显胸痛或后背放射痛
- 出现晕厥或意识丧失
- 呼吸困难、下肢水肿

风险等级：medium

【风险评估】

风险等级：中风险（medium）

【就医建议】

症状需要关注，建议尽快前往社区医院就诊。

【免责声明】

本报告内容仅供参考，不构成医疗诊断意见，如有不适请及时就医。